

DIE LETZTEN WOCHEN UND TAGE

Eine liebevolle Hilfe für Angehörige
in der Zeit des Sterbens

Sie müssen nicht alles wissen und nicht alles richtig machen.
Ihre Nähe, Ihre Stimme und Ihre liebevolle Aufmerksamkeit
können bereits sehr viel sein.

Susanne Schnepel
Sterbe- und Trauerbegleitung

Warum ich diese Broschüre erstellt habe

Wir sind nicht geübt im Abschiednehmen. Sterben und Tod gehören zum Leben, doch im Alltag sprechen wir nur selten darüber. Wenn ein geliebter Mensch seine letzte Lebenszeit erreicht, fehlen uns deshalb häufig die Worte. Wir wissen kaum, welche Fragen wir stellen dürfen, was auf uns zukommt und wie wir uns verhalten sollen.

Viele Angehörige möchten für ihren geliebten Menschen da sein und fühlen sich gleichzeitig hilflos, ängstlich oder unsicher.

Ich habe diese Broschüre erstellt, um Ihnen in dieser ganz besonderen Situation Orientierung und Sicherheit zu geben. Sie soll verständlich erklären, welche Veränderungen in der letzten Lebensphase möglich sind und wie Sie Ihren geliebten Menschen liebevoll begleiten können.

Wissen kann Unsicherheit verringern und helfen,
Veränderungen besser einzuordnen und den Blick wieder auf
das Wesentliche zu richten.

Diese Broschüre soll Raum schaffen – für Nähe, für Erinnerungen, für unausgesprochene Worte, für Versöhnung und für die Liebe.

Es geht nicht darum, alles richtig machen zu müssen. Oft sind es die kleinen Dinge, die besonders wertvoll sind: eine vertraute Stimme, eine haltende Hand, ein Lieblingslied, ein gemeinsames Gebet oder einfach das stille Dasein.

HALLO, ICH BIN SUSANNE

In Zeiten des Abschieds



Ich bin Susanne Schnepel.

Mit viel Herz begleite ich Menschen auf ihrem letzten Weg und stehe ihren Angehörigen in der Zeit des Abschieds zur Seite.

Durch meine Arbeit mit älteren, schwer erkrankten und demenziell veränderten Menschen weiß ich: Es braucht nicht immer viele Worte. Manchmal schenken eine haltende Hand, vertraute Musik, ein kleines Ritual oder stilles Dasein die größte Geborgenheit.

Mein Herzenswunsch ist es, Menschen einen liebevollen und würdevollen Abschied zu ermöglichen und Angehörige in dieser besonderen Zeit nicht allein zu lassen.

Mit Herz an Ihrer Seite – in der Zeit des Abschieds.

Susanne Schnepel

Sterbe- und Trauerbegleiterin · Zertifizierte Trauerrednerin

Wie diese Broschüre Sie begleitet

Vielleicht fühlen Sie sich gerade unsicher, hilflos oder von vielen Fragen überwältigt. Das ist verständlich, denn wir sind kaum darin geübt, einen geliebten Menschen beim Sterben zu begleiten.

Diese Broschüre begleitet Sie Schritt für Schritt:

- wenn die Kräfte eines geliebten Menschen nachlassen,
- wenn sich sein Körper und seine Wahrnehmung verändern,
- wenn Sie sich fragen, was Sie tun oder sagen können,
- während der letzten Tage und Stunden,
- im Augenblick des Sterbens,
- beim ersten Abschied nach dem Tod
- und bei den ersten Schritten in Ihre eigene Trauer.

Sie erhalten verständliche Informationen, praktische Anregungen und kleine liebevolle Rituale. Die Broschüre möchte Orientierung geben, Unsicherheit verringern und Raum schaffen für Nähe, Erinnerungen und Liebe.

Sie sind hier richtig

Sie müssen nicht alles auf einmal lesen. Schlagen Sie einfach die Seite auf, die Sie in diesem Moment gerade brauchen. Ihre Zuwendung und Ihr Dasein sind bereits sehr wertvoll.

Liebe Angehörige,

wenn ein geliebter Mensch schwächer wird und das Leben sich seinem Ende nähert, verändert sich vieles. Vertraute Abläufe verlieren ihre Bedeutung. Fragen, Angst, Hoffnung, Müdigkeit und tiefe Liebe können gleichzeitig da sein.

Diese Broschüre möchte Ihnen Orientierung geben. Sie beschreibt mögliche Veränderungen, nennt kleine Möglichkeiten der Begleitung und erinnert Sie daran, dass auch Sie Unterstützung verdienen.

Wichtig

Jeder Mensch stirbt auf seine eigene Weise. Nicht alle beschriebenen Zeichen treten auf. Aus einzelnen Veränderungen lässt sich der genaue Todeszeitpunkt nicht sicher vorhersagen.

Wenn Sie gerade am Bett sitzen

Bleiben Sie ruhig und sprechen Sie leise. Bei neuen oder belastenden Schmerzen, Atemnot, Blutungen, starker Unruhe, plötzlich ausgeprägter Verwirrtheit oder Unsicherheit informieren Sie bitte das Pflege- oder Behandlungsteam. Bei einem erwarteten Sterbeprozess gilt der vereinbarte Notfallplan. Sie müssen die Situation nicht allein beurteilen.

Legen Sie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und – falls vorhanden – die ärztliche Notfallanordnung gut sichtbar neben das Bett.

Sie dürfen fragen. Sie dürfen sich ablösen lassen. Und Sie dürfen einfach da sein.

Was Sie in dieser Broschüre finden

- Warum diese Broschüre entstanden ist und wer Sie begleitet
- Wie Sie diese Broschüre in Ihrer Situation nutzen können
- Wenn sich die letzte Lebensphase ankündigt
- Mögliche Veränderungen in den letzten Wochen und Tagen
- Essen, Trinken und Mundpflege
- Atmung, Schmerzen und körperliches Wohlbefinden
- Unruhe, Rückzug und besondere Wahrnehmungen
- Was Sie sagen, tun und lassen dürfen
- Nähe, Berührung, Düfte, Musik und kleine Rituale
- Wenn Kinder dabei sind
- Der Augenblick des Sterbens
- Die erste Zeit nach dem Tod
- Selbstfürsorge, Abschied und Unterstützung
- Platz für Wünsche, Kontakte und Notizen

Lesen Sie nur das, was Ihnen im Augenblick guttut. Sie müssen diese Broschüre nicht von vorn bis hinten durcharbeiten.

Wenn die Kräfte nachlassen

Oft beginnt der Abschied leise. Der erkrankte Mensch schläft mehr, wird schneller müde und braucht Hilfe bei Dingen, die vorher noch möglich waren. Gespräche werden kürzer, Besuche können anstrengend sein, und das Interesse an der Außenwelt nimmt manchmal ab.

Mögliche Veränderungen sind:

- mehr Ruhe- und Schlafbedürfnis
- weniger Kraft beim Aufstehen, Waschen oder Ankleiden
- weniger Appetit und kleinere Trinkmengen
- kürzere Aufmerksamkeit und weniger Gesprächsbedarf
- Rückzug, aber manchmal auch ein besonderes Bedürfnis nach Nähe
- wechselnde gute und sehr schwache Stunden oder Tage

Solche Veränderungen können zum fortschreitenden Krankheits- und Sterbeprozess gehören, können aber auch andere Ursachen haben. Bei neuen oder belastenden Veränderungen fragen Sie bitte das behandelnde Team.

Versuchen Sie, den Tagesrhythmus nicht zu erzwingen. Was heute noch Freude macht, kann morgen zu viel sein. Fragen Sie einfach: „Was wäre jetzt angenehm?“

Nicht die Menge dessen, was noch geschieht, ist entscheidend – sondern ob es dem Menschen entspricht.

Mögliche Zeichen der letzten Tage

In den letzten Tagen oder Stunden verändern sich viele Körperfunktionen zunehmend. Manche der folgenden Zeichen können dabei auftreten. Für Angehörige kann das ungewohnt und beängstigend wirken. Viele Veränderungen gehören zum natürlichen Sterbeprozess.

- Der Mensch schläft fast nur noch und reagiert wenig oder gar nicht.
- Das Bedürfnis nach Essen und Trinken kann abnehmen; das Schlucken kann schwerfallen. Wünsche und Wohlbefinden bleiben wichtig.
- Hände, Füße oder Knie können kühl werden; die Haut kann blass oder fleckig aussehen.
- Der Puls kann schwächer oder unregelmäßig werden.
- Die Atmung kann sich verändern, Pausen machen oder geräuschvoll klingen.
- Urin und Stuhl werden meist weniger; Ausscheidungen können sich verändern.
- Der Blick wirkt manchmal in die Ferne gerichtet; die Augen können halb geöffnet bleiben.

Beobachten Sie nicht allein. Lassen Sie sich vom Pflege- oder Palliativteam erklären, was gerade geschieht und was gelindert werden kann.

Essen und Trinken

Für viele Angehörige bedeutet Nahrung Fürsorge. Deshalb kann es schwer auszuhalten sein, wenn ein Mensch kaum noch essen oder trinken möchte. In der Sterbephase kann der Körper Nahrung und Flüssigkeit oft nicht mehr wie früher verarbeiten. Fehlender Appetit ist dann nicht automatisch ein Zeichen von Leiden.

Hilfreich kann sein:

- kleine Lieblingsportionen anbieten, aber nicht drängen
- nur im wachen Zustand und bei sicherem Schlucken etwas geben
- aufrechte oder gut gelagerte Position beim Trinken und Essen
- Lieblingsgetränke teelöffelweise anbieten, wenn es gut möglich ist
- bei Husten, Verschlucken oder Unsicherheit sofort pausieren und Fachpersonal fragen

Sicherheit

Bitte niemals Essen oder Flüssigkeit gegen den Willen geben. Bei Schluckstörungen besteht die Gefahr, dass etwas in die Atemwege gelangt.

Gut zu wissen

Weniger Trinken gehört häufig zum natürlichen Sterbeprozess. Ein trockener Mund bedeutet nicht automatisch Durst. Regelmäßige Mund- und Lippenpflege kann deshalb besonders wohltuend sein. Auch Infusionen lindern einen trockenen Mund nicht zuverlässig.

Ein feuchter Mund schenkt Wohlbefinden

In der letzten Lebensphase trinken viele Menschen nur noch wenig. Ein trockener Mund kann trotzdem unangenehm sein. Regelmäßige, liebevolle Mundpflege schenkt Erfrischung und Wohlbefinden.

Auch vertraute Lieblingsgeschmäcker können Wohlbefinden schenken – zum Beispiel der Geschmack eines gewohnten Lieblingsgetränks. Wenn das Schlucken nicht mehr sicher ist, können Lippen und Mundraum nach Anleitung des Pflegeteams vorsichtig befeuchtet und gepflegt werden.

Nach Anleitung des Pflegeteams können Sie außerdem:

- Lippen schützen und die Mundschleimhaut vorsichtig mit einem geeigneten, nur leicht angefeuchteten Hilfsmittel pflegen
- kleine Mengen eines vertrauten Getränks zur Mundpflege verwenden; alkoholhaltige Getränke nur nach Rücksprache und nur in sehr kleinen Mengen
- Eisstückchen nur nach individueller fachlicher Empfehlung verwenden; sie sind nicht für jeden Menschen geeignet
- Zunge, Mundschleimhaut und Zähne sanft reinigen und Auffälligkeiten melden

Bitte beachten

Geben Sie keine Getränke zum Schlucken und lassen Sie keine Flüssigkeit in den Mund laufen, wenn der Mensch nicht ausreichend wach ist oder unsicher schluckt. Vorsichtige Mundpflege ist davon zu unterscheiden. Bei Husten, Abwehr oder Unwohlsein pausieren und das Pflegeteam fragen.

Wenn die Atmung sich verändert

Die Atmung kann flacher, schneller, langsamer oder unregelmäßig werden. Längere Atempausen sind möglich. Ein rasselndes Geräusch entsteht häufig durch Sekret, das nicht mehr gut abgehustet oder geschluckt werden kann. Das Geräusch belastet Angehörige oft stärker als den sterbenden Menschen.

Was Sie tun können:

- ruhig bleiben, leise sprechen und für eine ruhige Umgebung sorgen – wenn es als angenehm empfunden wird, auch für frische Luft
- beengende Kleidung lockern
- eine als angenehm empfundene Lagerung ermöglichen – mit Hilfe des Pflegeteams
- bei sichtbarer Atemnot, Angst oder Unruhe sofort das Behandlungsteam informieren
- Bedarfsmedikamente nur nach ärztlicher Anordnung und durch zuständige oder ausdrücklich eingewiesene Personen geben

Wann Hilfe nötig ist

Bei einem erwarteten Sterbeprozess gilt der zuvor mit dem ärztlichen oder pflegerischen Team vereinbarte Notfallplan. Bei einer plötzlich lebensbedrohlichen oder ungeklärten Situation gilt 112.

Beschwerden erkennen und lindern

Auch wenn ein Mensch kaum noch sprechen kann, können Mimik, Körperhaltung und Verhalten Hinweise geben. Achten Sie auf Stirnrunzeln, Stöhnen, Abwehr, angespannte Hände, Unruhe oder Schonhaltung.

Melden Sie Veränderungen möglichst konkret:

- Was beobachten Sie genau?
- Seit wann ist es anders?
- Wann wird es stärker oder schwächer?
- Welche Maßnahme oder welches Medikament wurde bereits gegeben?
- Hat sich danach etwas verändert?

Schmerz, Übelkeit, Angst, Luftnot und Unruhe können häufig gelindert werden. Medikamente sollten rechtzeitig, nach ärztlicher Anordnung und nicht erst in größter Not eingesetzt werden.

Neue oder deutlich zunehmende Beschwerden sollten dem Behandlungsteam mitgeteilt werden. Nicht jede Veränderung muss als unvermeidlicher Teil des Sterbens hingenommen werden.

Sie müssen Beschwerden nicht aushalten oder allein beurteilen. Nachfragen ist Fürsorge.

Zwischen Wachsein, Traum und Rückzug

Sterbende Menschen wirken manchmal weit entfernt. Sie sprechen mit Menschen, die andere nicht sehen, greifen in die Luft oder erzählen, sie müssten bald aufbrechen. Solche Erlebnisse können tröstlich, neutral oder beängstigend sein.

Sie müssen nicht widersprechen oder beweisen, was wirklich ist. Sie können auf das Gefühl antworten:

- „Du wirkst ganz ruhig, wenn du davon erzählst.“
- „Macht dir das Angst?“
- „Ich bin bei dir.“
- „Erzähl mir, wenn du möchtest, wen du siehst.“

Plötzliche starke Verwirrtheit, Angst, Halluzinationen oder Unruhe können auch behandelbare Ursachen haben. Informieren Sie deshalb das Behandlungsteam – besonders wenn der Mensch leidet oder sich gefährdet.

Nicht jedes ungewöhnliche Erleben muss korrigiert werden.
Entscheidend ist: Fühlt der Mensch sich sicher und geborgen?

Wenn Unruhe entsteht

Manche Menschen nesteln an der Bettdecke, wollen aufstehen, rufen, suchen etwas oder wirken gehetzt. Dahinter können Schmerzen, Harndrang, Verstopfung, Atemnot, Angst, Medikamente oder eine veränderte Wahrnehmung stehen.

Das kann helfen:

- eine ruhige Stimme und nur wenige Menschen im Zimmer
- kurze, einfache Sätze statt vieler Fragen
- vertraute Musik oder ein bekanntes Gebet
- Hand halten oder sanft berühren – nur wenn es angenehm ist
- Brille und Hörgerät anbieten, wenn sie sonst getragen werden
- für eine sichere Umgebung sorgen und fachliche Hilfe holen; den Menschen nicht eigenmächtig festhalten oder fixieren

Sagen Sie dem Team, wenn die Unruhe neu ist, anhält oder belastend wirkt. Es gibt oft Möglichkeiten, Ursachen zu behandeln und Angst zu lindern.

Was darf ich sagen?

Viele Angehörige fürchten, das Falsche zu sagen. Es braucht keine perfekten Worte. Ehrlichkeit, Wärme und einfache Sätze reichen.

Mögliche Worte sind:

- „Ich bin bei dir.“
- „Du bist nicht allein.“
- „Danke für alles, was wir miteinander hatten.“
- „Ich habe dich lieb.“
- „Um das, was jetzt wichtig ist, kümmern wir uns. Du darfst dich ausruhen.“
- „Ich gehe kurz hinaus und komme wieder.“

Auch ohne sichtbare Reaktion kann Ihre Stimme vertraut sein. Sprechen Sie den sterbenden Menschen weiterhin respektvoll an – und nicht über ihn, als wäre er nicht anwesend. Wählen Sie nur Worte, die sich für Sie beide stimmig anfühlen.

Schweigen ist ebenfalls Begleitung. Sie dürfen einfach sitzen, atmen und die Hand halten.

Mit allen Sinnen begleiten

Vertraute Klänge, Bilder und Berührungen können Sicherheit und Geborgenheit schenken. Weniger ist dabei oft mehr. Beobachten Sie, ob sich Gesicht und Körper entspannen oder ob etwas eher anstrengend wirkt.

- eine Lieblingsmusik leise abspielen
- ein vertrautes Foto oder einen persönlichen Gegenstand in Sichtweite stellen
- eine Hand- oder Fußberührung anbieten
- einen bekannten Text, Psalm, Segen oder eine kurze Geschichte lesen
- das Zimmer mit gedämpftem Licht und wenigen Reizen gestalten

Vertraute Düfte können angenehm sein und Erinnerungen wecken, aber auch Übelkeit oder Atembeschwerden auslösen. Verwenden Sie ätherische Öle nicht eigenständig auf Haut, Schleimhäuten oder in hoher Raumkonzentration. Fragen Sie vorher nach Verträglichkeit und fachlicher Empfehlung.

Kleines Ritual: Zünden Sie – wenn es sicher und erlaubt ist – eine Kerze oder LED-Kerze an. Nehmen Sie sich einen stillen Moment. Wenn Sie möchten, sagen Sie: „Dieses Licht steht für unsere Verbundenheit.“

Wenn Kinder Abschied nehmen

Kinder spüren, wenn etwas geschieht. Klare, altersgerechte Worte helfen meist mehr als Beschönigungen. Sagen Sie zum Beispiel: „Opa ist sehr krank. Sein Körper wird immer schwächer. Wahrscheinlich wird er bald sterben.“

Hilfreich ist:

- Fragen ehrlich beantworten und auch „Ich weiß es nicht“ sagen dürfen
- Kinder selbst entscheiden lassen, ob und wie lange sie ins Zimmer möchten – ein Kind darf seine Meinung auch wieder ändern und den Raum jederzeit verlassen
- vorher erklären, wie der Mensch aussehen, atmen oder reagieren könnte
- eine vertraute erwachsene Person nur für das Kind dabei haben
- Malen, Vorlesen, ein Bild schenken oder eine Blume hinlegen ermöglichen
- klarstellen: Das Kind ist nicht schuld und Sterben ist nicht ansteckend

Kinder trauern oft in kurzen Abschnitten: eben traurig, kurz darauf wieder spielend. Das ist kein Mangel an Liebe, sondern ihre natürliche Art, Belastendes zu verarbeiten.

Am Bett wachen – und trotzdem gehen dürfen

Viele Angehörige möchten keinen Augenblick verpassen. Gleichzeitig braucht der eigene Körper Schlaf, Essen, frische Luft und Ablösung. Angehörige berichten immer wieder, dass ein Mensch gerade in einem Moment stirbt, in dem sie kurz den Raum verlassen haben. Warum dies geschieht, lässt sich nicht sicher sagen.

- Vereinbaren Sie Ablösungen.
- Legen Sie Telefonnummern und den Notfallplan griffbereit.
- Bitten Sie das Team um eine ehrliche Einschätzung.
- Verabschieden Sie sich auch bei einem kurzen Weggehen bewusst.
- Erlauben Sie sich Ruhe, ohne sich schuldig zu fühlen.

Sie lassen den Menschen nicht im Stich, wenn Sie schlafen, essen oder nach Hause fahren. Ihre Liebe wird nicht an der Anzahl der Stunden am Bett gemessen.

Der Augenblick des Sterbens

Bei einem erwarteten Sterben kann die Atmung unregelmäßig werden und schließlich aussetzen; einzelne Atembewegungen sind möglich. Die Haut kann blasser werden, Mund und Augen können geöffnet bleiben. Angehörige müssen den Tod nicht selbst feststellen.

Nach einem erwarteten Tod

1. Bleiben Sie einen Moment sitzen. Sie müssen nichts überstürzen.
2. Berühren Sie den verstorbenen Menschen, wenn Sie möchten.

Wenn der Tod im Rahmen eines bekannten Sterbeprozesses eingetreten ist, folgen Sie dem zuvor mit Hausarzt, Pflegedienst, Pflegeeinrichtung, Hospiz- oder Palliativteam vereinbarten Ablauf. Eine Ärztin oder ein Arzt muss die erforderliche Leichenschau durchführen und die Todesbescheinigung ausstellen.

Bei einer plötzlich lebensbedrohlichen oder ungeklärten Situation

Wenn der Tod nicht erwartet wurde oder unklar ist, was geschehen ist, rufen Sie 112. Zeigen Sie dem Rettungsdienst, falls vorhanden, Patientenverfügung und ärztliche Notfallanordnung.

Wenn Sie nicht beim letzten Atemzug dabei waren, haben Sie den Menschen nicht allein gelassen. Begleitung besteht aus der ganzen gemeinsamen Zeit.

Die ersten Stunden danach

Nach der ärztlichen Feststellung des Todes bleibt in vielen Situationen Zeit für einen persönlichen Abschied. In einer Einrichtung können Sie nach den dortigen Abläufen fragen. Zu Hause besprechen Sie das weitere Vorgehen mit Arzt, Ärztin und Bestattungsunternehmen.

Vielleicht möchten Sie:

- still sitzen, beten oder Musik hören
- die Hand halten oder die Stirn berühren
- eine Blume, einen Brief oder ein Erinnerungszeichen dazulegen
- Familienmitglieder informieren und ihnen Abschied ermöglichen
- nach Absprache mit dem Pflegepersonal bei der letzten Versorgung dabei sein oder kleine Handgriffe übernehmen
- ein Fenster öffnen – als persönliches Symbol, wenn es für Sie stimmig ist

Es gibt kein vorgeschriebenes Gefühl. Erleichterung, Leere, Frieden, Unglaube und tiefer Schmerz können nebeneinanderstehen.

Lassen Sie sich erklären, welche Schritte jetzt notwendig sind und welche noch warten dürfen. In diesem Moment muss nicht alles entschieden werden.

Auch Sie brauchen Begleitung

Sterbebegleitung kann körperlich und seelisch erschöpfen. Ihre Bedürfnisse zählen. Hilfe anzunehmen ist kein Versagen, sondern ermöglicht, dass Sie länger liebevoll präsent bleiben können.

Ein kleiner Anker für heute:

- Ich trinke ein Glas Wasser.
- Ich esse eine Kleinigkeit.
- Ich gehe für fünf Minuten an die frische Luft.
- Ich sage einer Person ehrlich, was ich gerade brauche.
- Ich schlafe oder ruhe, wenn eine Ablösung möglich ist.
- Ich erlaube mir Tränen – und auch ein Lächeln.

Ein kleiner Ruhepunkt: Wenn es Ihnen guttut, legen Sie eine Hand auf Ihr Herz und atmen Sie einige Male ruhig ein und aus. Bei Schwindel oder Unwohlsein hören Sie auf. Sagen Sie innerlich: „Ich bin hier. Ich muss diesen Weg nicht allein gehen.“

ZUM EINTRAGEN

Mein Begleitplan

Behandelnde Ärztin / behandelnder Arzt	Telefon
Pflegedienst / Pflegeeinrichtung	Telefon
Palliativteam / SAPV (rund um die Uhr)	Telefon
Ambulanter Hospizdienst	Telefon
Seelsorge	Telefon
Bestattungsunternehmen	Telefon
Nachts / am Wochenende erreichbar	Telefon
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117	Plötzliche Lebensgefahr: 112

Vorsorge und Wünsche

Patientenverfügung vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein Wo liegt sie? _____

Vorsorgevollmacht / bevollmächtigte Person: _____

Telefon: _____

Vereinbarter Notfall-/Bedarfsplan vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein

Wo liegt er? _____

Wichtige Behandlungswünsche / Wünsche für die letzte Lebensphase: _____

Was dem sterbenden Menschen sonst wichtig ist: _____

Ich brauche: _____

ZUM SCHLUSS

Sie dürfen sich begleiten lassen

Sterben ist kein Weg, den man vollständig planen oder beherrschen kann. Doch es kann ein Weg sein, auf dem Nähe, Würde, Wahrhaftigkeit und Liebe spürbar bleiben.

Vielleicht können diese Worte Sie tragen:

*„Ich kann den Weg nicht für dich gehen.
Aber ich kann ein Stück bei dir bleiben.“*

Gerne begleite ich Sie und Ihren geliebten Menschen – mit Zeit, Ruhe, Gesprächen, kleinen Ritualen und einem offenen Ohr.

Susanne Schnepel

Sterbe- und Trauerbegleiterin · Zertifizierte Trauerrednerin

Telefon: 0178 530 9989 · gerne per WhatsApp

E-Mail: info@trauer-begleiten.com

www.trauer-begleiten.com

Fachliche Grundlagen

Diese Broschüre ist aus meinen Erfahrungen in der Sterbe- und Trauerbegleitung sowie aus meiner Arbeit mit älteren, schwer erkrankten und demenziell veränderten Menschen entstanden.

Die medizinischen und pflegerischen Informationen orientieren sich insbesondere an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin zur Begleitung in der Sterbephase, an der S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung und an Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit zur Hospiz- und Palliativversorgung.

Persönliche Texte, Rituale und Anregungen spiegeln meine Haltung und Erfahrungen in der Begleitung wider. Sie sind von medizinischen Empfehlungen zu unterscheiden.

Diese Broschüre dient der Orientierung und Unterstützung. Sie ersetzt keine individuelle medizinische, pflegerische oder rechtliche Beratung. Bei Beschwerden, Unsicherheit oder einer Veränderung der Situation wenden Sie sich bitte an das behandelnde Pflege-, ärztliche oder Palliativteam. In Einrichtungen gelten zusätzlich die jeweiligen internen Regelungen.

Quellen

- Leitlinienprogramm Onkologie: S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patient:innen mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung, Version 3.0, Juli 2026 (AWMF-Registernummer 128-001OL).
- Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Sektion Ernährung: Essen und Trinken in der letzten Lebensphase. August 2026. www.dgpalliativmedizin.de
- Bundesministerium für Gesundheit: Hospiz- und Palliativversorgung. www.bundesgesundheitsministerium.de (abgerufen im Oktober 2026).

Stand: Oktober 2026 · © 2026 Susanne Schnepel. Diese Broschüre darf unverändert und kostenfrei weitergegeben, ausgedruckt und geteilt werden. Veränderungen, Auszüge oder eine kommerzielle Nutzung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung.